==========

HOSPITAL MUNICIPAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

REGISTRO GERAL (RG): 852963-Y | LEITO: 208-UTI | ADMISSÃO: 10/07/2026

PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA | DATA DE NASCIMENTO: 05/03/1962 (64 ANOS)

==========

[PÁGINA 1 DE 3] - BOLETIM DE ADMISSÃO E EVOLUÇÃO MÉDICA INICIAL

DATA: 10/07/2026 - 10:15h - ADMISSÃO (PRONTO ATENDIMENTO)

Médico Responsável: Dr. Fernando Rocha - CRM/SP 135790

Histórico: Paciente dá entrada no PA relato de quadro gripal há 4 dias (coriza, odinofagia, mialgia e febre baixa de 37.8°C). Hoje evoluiu com prostração, adinamia e sensação de falta de ar aos médios esforços.

Diagnóstico de Entrada: SÍNDROME GRIPAL NÃO ESPECIFICADA.

CID-10 de Admissão: J11.1

Conduta Inicial: Prescritos sintomáticos, hidratação e aferição contínua de sinais vitais. Coletado RT-PCR para vírus respiratórios.

MAPA DE SINAIS VITAIS E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM (10/07 a 12/07)

(Folha 02 a 06 - Registro Diário)

10/07/2026:

- 11:00h: Aferição de Pressão Arterial (130x80 mmHg) - Enfª Renata

- 11:30h: Coleta de swab nasofaríngeo para RT-PCR (Painel Viral) - Tec. Bruno

- 12:00h: Teste de Glicemia Capilar (125 mg/dL) - Tec. Bruno

- 15:00h: Aferição de Pressão Arterial (135x85 mmHg) - Tec. Bruno

- 18:00h: Aplicação de medicação Intramuscular (Sintomático) - Tec. Bruno

- 22:00h: Teste de Glicemia Capilar (130 mg/dL) - Tec. Bruno

11/07/2026:

- 06:00h: Aferição de Pressão Arterial (140x90 mmHg) - Enfª Renata

- 07:00h: Teste de Glicemia Capilar (145 mg/dL) - Enfª Renata

- 10:00h: Curativo Simples em sítio de punção venosa periférica - Tec. Bruno

- 14:00h: Aferição de Pressão Arterial (138x88 mmHg) - Tec. Bruno

- 18:00h: Aplicação de medicação Intramuscular - Tec. Bruno

- 22:00h: Teste de Glicemia Capilar (150 mg/dL) - Tec. Bruno

12/07/2026:

- 06:00h: Aferição de Pressão Arterial (145x95 mmHg) - Enfª Renata

- 07:00h: Teste de Glicemia Capilar (168 mg/dL) - Enfª Renata

- 08:30h: Resultado de Exame RT-PCR liberado: POSITIVO PARA SARS-CoV-2.

- 09:00h: Paciente evolui com dessaturação importante (SpO2 88% em ar ambiente) e taquipneia (FR 28 irpm).

- 09:30h: Instalada Oxigenoterapia sob Máscara de Reservatório a 10L/min.

- 14:00h: Aferição de Pressão Arterial (150x90 mmHg) - Tec. Bruno

==========

[PÁGINA 2 DE 3] - AGRAVAMENTO CLÍNICO E TRANSFERÊNCIA PARA UTI

DATA: 13/07/2026 - 03:00h - PARECER DA INTENSIVA (UTI)

Médico Responsável: Dra. Camila Siqueira - CRM/SP 246810

Evolução: Paciente evoluiu com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) grave secundária a infecção por COVID-19. Necessidade de suporte ventilatório invasivo imediato.

Transferência Imediata para UTI Isolation.

MUDANÇA DO QUADRO PRINCIPAL / DIAGNÓSTICO: COVID-19 - INFECÇÃO POR CORONAVÍRUS COM COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS GRAVES.

NCS / CID-10 Atualizado: B34.2 (Infeccao por Coronavirus) / U07.1 (COVID-19, virus identificado).

PROCEDIMENTOS E NOTAS DE ENFERMAGEM UTI (13/07 a 19/07)

(Folha 08 a 22 - Registro UTI)

- 13/07 às 03:30h: Realizada Intubação Orotraqueal (IOT) e início de Ventilação Mecânica Invasiva (VMI).

- 13/07 às 04:15h: Passagem de Cateter Venoso Central (CVC) em veia subclávia esquerda para infusão de drogas vasoativas - Dra. Camila Siqueira.

- Mantida em Ventilação Mecânica Invasiva (13/07 a 18/07 - Total: 6 diárias de Suporte Ventilatório / VMI).

- Curativo Complexo/Especial (Grau II) em sítio de inserção de CVC e fixação de tubo orotraqueal:

  * 13/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

  * 14/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

  * 15/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

  * 16/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

  * 17/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

  * 18/07 às 14:00h (Enfª Luciana)

Aferições de Sinais Vitais em UTI (13/07 a 19/07):

- 13/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 4 Testes de Glicemia Capilar

- 14/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 4 Testes de Glicemia Capilar

- 15/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 4 Testes de Glicemia Capilar

- 16/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 4 Testes de Glicemia Capilar

- 17/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 3 Testes de Glicemia Capilar

- 18/07: 6 Aferições de Pressão Arterial | 3 Testes de Glicemia Capilar

- 19/07: 4 Aferições de Pressão Arterial | 2 Testes de Glicemia Capilar

==========

[PÁGINA 3 DE 3] - EXTUBAÇÃO, ENFERMARIA DE TRANSIÇÃO E ALTA

DATA: 19/07/2026 a 21/07/2026 - DESMAME E ENFERMARIA

Médico Responsável: Dr. Fernando Rocha - CRM/SP 135790

19/07/2026: Sucesso no protocolo de desmame ventilatório. Extubação orotraqueal realizada às 09:00h sem intercorrências. Mantida sob oxigenoterapia de transição via cateter nasal (19/07 a 20/07 - Total: 2 diárias de O2).

20/07/2026: Transferida para enfermaria. Retirado Cateter Venoso Central.

- 10:00h: Curativo Simples em local de occlusão da subclávia

- 14:00h: Aplicação de medicação Intramuscular

- 18:00h: Aferição de Pressão Arterial (120x80 mmHg)

- 22:00h: Teste de Glicemia Capilar (118 mg/dL)

21/07/2026 - 10:00h - ALTA HOSPITALAR (12º DIA DE INTERNAÇÃO)

Paciente estável, eupnéica em ar ambiente, afebril, com exames laboratoriais de controle satisfatórios.

Diagnóstico Definitivo de Alta para Encerramento da AIH: Infecção por Coronavírus - COVID-19 com complicações pulmonares (CID-10: U07.1 / B34.2) com histórico inicial de Síndrome Gripal (CID-10: J11.1).

==========